

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

TQ · TRAUMA QUESTIONNAIRE

Cuestionario para Experiencias Traumáticas de Davidson – Inventario sistemático de cribado biográfico de acontecimientos estresantes extremos y trauma acumulado

1. Identificación General del Instrumento

Nombre oficial	Trauma Questionnaire (TQ / Davidson Trauma Questionnaire)
Nombre en español	Cuestionario para Experiencias Traumáticas
Sigla oficial	TQ
Autores originales	Jonathan R. T. Davidson, Dana Hughes y Dan G. Blazer (1990, 1996)
Adaptación hispanohablante	Julio Bobes et al. (2000, 2004); Banco de Instrumentos Básicos / CIBERSAM
Año de publicación original	1990 (estudio pionero epidemiológico; adaptación española en 2000)
Construto primario	Exposición acumulada a sucesos vitales traumáticos que cumplen el Criterio A del TEPT (DSM)
Formato de administración	Autoinforme estructurado o entrevista guiada con registro de ocurrencia (Sí/No), edad y duración
Población diana	Población adolescente y adulta (≥ 14 años) evaluada por sospecha de patología postraumática
Tiempo de aplicación	8 a 12 minutos (18 acontecimientos traumáticos potenciales)
Régimen de acceso	Uso clínico y de investigación abierto de libre disposición respetando citación de autoría

2. Fundamentación Conceptual y Marco Clínico

El **Cuestionario para Experiencias Traumáticas (TQ)** fue desarrollado por Jonathan R. T. Davidson y sus colaboradores en la Universidad de Duke para sistematizar de forma rigurosa la anamnesis del **Criterio A** diagnóstico para el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). En la clínica psiquiátrica cotidiana, los pacientes a menudo omiten u ocultan vivencias traumáticas decisivas de su infancia o juventud debido a la vergüenza, el dolor emocional o la amnesia disociativa, lo que conduce con frecuencia a diagnósticos erróneos de depresión resistente o trastornos de personalidad.

El TQ ofrece un catálogo operativo y estructurado de 18 categorías de sucesos vitales catastróficos que implican peligro inminente de muerte, lesiones corporales graves o violencia sexual, categorizados en: 1) accidentes graves de tráfico o industriales; 2) desastres naturales masivos (incendios, inundaciones, terremotos); 3) violencia interpersonal intencional (asaltos a mano armada, secuestros, tortura, combate bélico); 4) violencia física y abusos continuados en la infancia o edad adulta; y 5) experiencias de agresión sexual, violación e incesto intrafamiliar. Permite cuantificar el **Índice de Carga Traumática Acumulada** e identificar con precisión el **Trauma Índice** (el suceso más perturbador) sobre el cual se aplicarán posteriormente las escalas de síntomas (como la DTS o CAPS).

3. Dominios Evaluados y Composición de Ítems

Categoría Traumática TQ	N.º Ítems	Rango	Contenido Clínico y Operacionalización
1. Accidentes y Catástrofes	6 ítems	0 – 6	Accidente de tráfico grave (ítem 1), industrial/explosión (2), incendio (3), inundación (4), tornado/huracán (5) y terremoto (6).
2. Amenaza a Allegados / Duelo	2 ítems	0 – 2	Amenaza/agresión física grave a un familiar íntimo (ítem 7) y muerte repentina/violenta de ser querido (ítem 8).
3. Riesgo Físico y Maltrato	4 ítems	0 – 4	Peligro de asfixia/ahogamiento (ítem 9), maltrato físico continuado (10), quemaduras graves (11) y toma como rehén (12).
4. Violencia Interpersonal y Guerra	3 ítems	0 – 3	Zona de combate bélico activo (ítem 13), asalto armado/atraco (14) y secuestro o extorsión violenta (17).
5. Violencia Sexual y Miscelánea	3 ítems	0 – 3	Violación/intento de violación (ítem 15), abuso sexual en la infancia/incesto (16) y otro suceso extremo (18).
Carga Traumática Total	18 ítems	0 – 18	Recuento simple de experiencias traumáticas sufridas a lo largo de la biografía (Sí = 1, No = 0).

4. Validez, Confiabilidad y Rendimiento Diagnóstico en España / LatAm

Propiedad Métrica	Coefficiente / Hallazgo	Contexto Empírico y Validación Hispana
Fiabilidad test-retest biográfica	Kappa = 0.82 – 0.91 (1 mes)	Excelente reproducibilidad en la notificación retrospectiva de eventos vitales mayores.
Validez de constructo / Criterio A	Sensibilidad > 95% para trauma	Identifica de forma exhaustiva los estresores biográficos requeridos para el diagnóstico formal de TEPT.
Predicción de patología psiquiátrica	Odds Ratio = 1.45 por cada evento	Relación dosis-respuesta lineal entre número de traumas sufridos y gravedad psicopatológica posterior.
Asociación con TEPT Complejo	Correlación $r = 0.65$ con DES-II	El abuso interpersonal temprano (ítems 10, 15, 16) correlaciona fuertemente con disociación severa.
Concordancia con entrevista clínica	Kappa = 0.88	Alta concordancia entre el autoinforme del TQ y la historia biográfica clínica dirigida.

5. Reglas de Corrección y Cómputo de Puntuaciones

- **Calificación dicotómica:** Cada uno de los 18 sucesos se responde con **SÍ (1 punto)** o **NO (0 puntos)**.
- **Variables cualitativas asociadas:** Para cada evento contestado afirmativamente, se anota:
 - **Edad de ocurrencia:** Permite distinguir traumas tempranos del neurodesarrollo (< 18 años) frente a traumas del adulto.
 - **Duración / Cronicidad:** Evento agudo puntual (accidente) frente a trauma interpersonal continuado (abusos de años).
- **Índice de Carga Traumática Acumulada:** Recuento total de sucesos confirmados (rango: 0 a 18 acontecimientos).
- **Selección del “Trauma Índice”:** El paciente debe señalar cuál de los acontecimientos marcados como afirmativos es el que le provoca mayor perturbación o reviviscencias en el momento actual.

6. Baremos Normativos, Puntos de Corte y Estratificación Clínica

N.º de Traumas	Categoría de Exposición	Significación Clínica y Vulnerabilidad Psicopatológica
0 eventos	Sin Exposición Traumática	No cumple el Criterio A para TEPT. Explorar otros motivos de consulta afectivos o ansiosos.
1 acontecimiento	Trauma Simple / Único	Exposición a un estresor puntual (ej. accidente de tráfico). Buen pronóstico con tratamiento focalizado.
2 – 3 acontecimientos	Politraumatización Moderada	Mayor vulnerabilidad alostática. Riesgo elevado de cronificación sintomática y depresión reactiva comórbida.
≥ 4 acontecimientos (o trauma infantil)	Traumatización Compleja / Severa	Alto riesgo de TEPT Complejo (TEPT-C) , fenómenos disociativos graves, somatizaciones múltiples e inestabilidad de la personalidad.

REGLA METODOLÓGICA FUNDAMENTAL (DAVIDSON ET AL., 1990): El TQ no es una escala de severidad sintomática, sino un **inventario de exposición biográfica**. Su función es acreditar el Criterio A e identificar el **Trauma Índice**, condición indispensable previa para evaluar la gravedad del TEPT mediante la DTS, TOP-8 o CAPS.

7. Algoritmo de Decisión Clínica e Intervención Asistencial

Paso 1: Administración en la evaluación biográfica inicial:

- Aplicar el TQ en pacientes con clínica afectiva resistente, ataques de pánico no filiados, conductas autolesivas o antecedentes de marginalidad.

Paso 2: Análisis cualitativo de la tipología del trauma:

- **Trauma Tipo I (Monotraumático / Accidental):** Accidente o desastre puntual en la edad adulta (ítems 1 a 6). Proceder a la evaluación directa de síntomas con la TOP-8 o DTS. Abordaje prioritario con EMDR o TCC focalizada en el trauma.
- **Trauma Tipo II (Complejo / Interpersonal Temprano):** Maltrato, abusos sexuales o violencia continuada en la infancia (ítems 10, 15, 16). Exige una fase inicial prolongada de estabilización emocional, seguridad y regulación del afecto antes de iniciar la exposición o reprocesamiento de recuerdos traumáticos.

Paso 3: Identificación del “Trauma Índice”:

- Solicitar al paciente que indique el acontecimiento más angustiante en la actualidad para anclar la monitorización psicométrica y terapéutica.

8. Caso Clínico Ilustrativo

Identificación: Mujer de 33 años, auxiliar de enfermería, remitida desde Atención Primaria con diagnóstico provisional de Trastorno Depresivo Recurrente resistente a dos ensayos farmacológicos, con frecuentes crisis de angustia nocturnas.

Resultados en el Cuestionario TQ:

- Carga Traumática Acumulada: **4 acontecimientos positivos**.
- Sucesos confirmados:
 - Ítem 10 (Maltrato físico en la infancia por parte de su progenitor, desde los 7 a los 14 años).
 - Ítem 14 (Asalto con intimidación y robo violento en vía pública a los 22 años).
 - Ítem 15 (Agresión sexual consumada por un conocido a los 25 años).
 - Ítem 1 (Accidente de tráfico con conmoción cerebral leve a los 30 años).
- **Trauma Índice seleccionado por la paciente:** Ítem 15 (Agresión sexual).

Formulación Diagnóstica y Plan Asistencial: El TQ reveló que el cuadro depresivo resistente era secundario a un TEPT Complejo no diagnosticado. La identificación del abuso sexual como trauma índice permitió anclar la evaluación psicométrica de síntomas (DTS = 84 puntos) y desarticular la pauta ineficaz de polifarmacia. Se instauró psicoterapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR) precedida de entrenamiento en estabilización emocional (técnica del lugar seguro). A los 9 meses de tratamiento, la paciente remitió de los episodios de pánico y recuperó un descanso nocturno reparador.

9. Alertas de Seguridad y Diagnóstico Diferencial

ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA:

- **Riesgo de retraumatización:** Administrar el cuestionario con calidez terapéutica; no forzar detalles explícitos ni descripciones morbosas de los abusos durante la administración del cribado.
- **Aparición de disociación peritraumática:** Si el paciente se desconecta o muestra congelamiento durante la revisión del TQ, aplicar técnicas de anclaje sensorial inmediato (**grounding**).
- **Denuncias y aspectos forenses:** Conocer los protocolos médico-legales ante agresiones sexuales o maltrato de menores no prescrito.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

- **Trauma vs. Estresor ordinario:** Disidencias conyugales o desempleo son estresores severos pero NO cumplen el Criterio A (peligro inminente de muerte o daño grave).
- **Trastorno Límite de la Personalidad:** La alta concurrencia de trauma infantil en el TLP no debe confundirse con la sintomatología intrusiva y evitativa específica del TEPT.
- **Amnesia disociativa:** Explorar lagunas biográficas extensas en pacientes con sospecha fundada de abuso sexual en la infancia.

10. Referencias Bibliográficas Científicas

1. Davidson, J. R. T., Hughes, D., & Blazer, D. G. (1990). Traumatic experiences in psychiatric patients. *Journal of Traumatic Stress*, 3(3), 459–475. <https://doi.org/10.1002/jts.2490030314>
2. Davidson, J. R. T., Hughes, T. W., & Blazer, D. (1996). Post-traumatic stress disorder: Diagnostic and measurement aspects. *International Clinical Psychopharmacology*, 11(Suppl 3), 85–89.
3. Bobes, J., Calcedo-Ordóñez, A., García-Borreguero, D., Francois, M., Rico-Villademoros, F., González, M. P., ... & Grupo de Trabajo de TEPT. (2000). Evaluación de las propiedades psicométricas de la versión española de cinco cuestionarios para la evaluación del TEPT. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 28(4), 207–218.
4. Herman, J. L. (1992). Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeated trauma. *Journal of Traumatic Stress*, 5(3), 377–391. <https://doi.org/10.1002/jts.2490050305>